



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رعوث زكا جرجس صليب
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : امبابه
رقم البطاقة : 26203022600342 رقم التليفون : 01224495801
العنوان : ارض الجمعيه
العمر (تاريخ الميلاد) : 02-03-1962 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستماره : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دعوث زكا جرجس صليبي National ID: 26203022600342	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

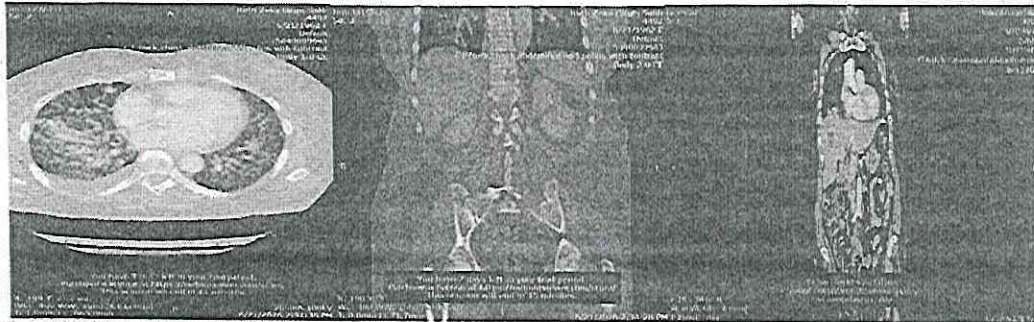
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient's Name: Ruth Zaka Girgis Salib
Date: 2026-06-21
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



MULTISLICE CT EXAMINATIUNON OF THE LOWER NECK, CHEST ,ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-

- Unremarkable the scanned lower neck structures.
- Bilateral variable sized axillary and retro-pectineal lymph nodes are seen with preserved their hilar fat contents and the largest one seen in the right axilla and measures about 23x11mm in dimensions.
- Mild right-sided pleural effusion with minimal left pleural thickening.
- Multiple variable sized enhancing pulmonary nodules are seen scattering in both lung fields with the largest one seen in the anterior segment of right lower pulmonary lobe and measures about 19x14mm in dimensions.
- Thickened interstitium/linear atelectatic bands are also seen scattering in both lung fields with honey-comb appearance of both lungs ,and bilateral increased broncho-vascular markings. A patchy area of consolidation is also seen in the apical segment of right lower pulmonary lobe.
- No sizable foci of calcifications noted.
- No sizable mediastinal or hilar lymph nodes seen.
- Patent central airways.
- No pericardial effusion.
- Border line size of the heart with mild atherosclerotic changes of its big vessels.
- Multiple osteolytic and to lesser extent osteosclerotic lesions are seen scattering in the scanned skeleton and reaching downwards to involve the pelvic bones ,bilaterally and in the upper aspect of both femurs.
- Mildly increased sized liver,measuring about 17 cm, showing a non-homogenous parenchymal attenuation and enhancement pattern.
- Multiple variable sized marginally-enhancing hepatic focal lesions are seen scattering in its lobes(more in the right lobe with the largest one seen in its anterior segment (segment V111) and measures about 42x39mm in dimensions).Two other similar rather tiny lesions are seen in segment 11 and 1Va of the left lobe . The later is alrger and measures about 8.7x8.6mm in dimensions.
- No dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen,measuring about 7.1 cm. No focal lesions seen inside.

Patient's Name: Ruth Zaka Girgis Salib
Date: 2026-06-21
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Thickened left adrenal gland.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, right adrenal gland, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- An irregular mucosal thickening of the gastric wall=12 mm.
- No intra-vesical stones, solid masses, or diverticulosis seen. An irregular thickening of the vesical wall is seen and reaches to about 7 mm.
- The rest of the pelvic organs are unremarkable.

IMPRESSIONS:

A known case of right breast cancer (its full clinical data is not available) and the current study shows:

- Mild right-sided pleural effusion with minimal left pleural thickening.
- Multiple variable sized bilateral enhancing metastatic pulmonary nodules,
- Thickened interstitium/linear atelectatic bands, scattering in both lung fields with honey-comb appearance of both lungs, bilateral increased broncho-vascular markings and a patchy area of consolidation also seen in the apical segment of right lower pulmonary lobe.
- Multiple osteolytic and to lesser extent osteosclerotic metastatic lesions scattering in the scanned skeleton and reaching downwards to involve the pelvic bones, bilaterally and in the upper aspect of both femurs. For whole body bone scanning.
- Multiple variable sized marginally-enhancing metastatic bilobar hepatic focal lesions.
- Thickened left adrenal gland. Metastatic rather than hyperplasia is impressive.
- An irregular mucosal thickening of the gastric wall, denoting a gastritis.
- An irregular thickening of the vesical wall, denoting a cystitis.

Prof/Hanan El-Ahwal.

Patient's Name:
Date:
Referred by:
Hospital:

Ruth Zaka Girgis Salib
2026-09-09
Prof.Dr. no doctor
Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT CONTRAST REVEALED:-

- Moderate right pleural effusion with underlying subsegmental lung collapse/consolidation.
- Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest measuring 12 x 10 mm at the left lower lobe.
- Multiple bilateral scattered ground glass densities and reticulations with interlobular septal thickening.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No left pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Multiple scattered vertebral, ribs and left clavicular lytic bone lesions.
- Upper abdominal cuts showed multiple variable sized bilobar hypodense hepatic focal lesions.

Opinion:-

- *Moderate right pleural effusion with underlying subsegmental lung collapse/consolidation.*
- *Multiple bilateral scattered pulmonary nodules, ground glass densities and reticulations with interlobular septal thickening ? metastatic for PET-CT assessment.*
- *Multiple scattered vertebral, ribs and left clavicular lytic bone lesions likely metastatic for bone scan.*
- *Upper abdominal cuts showed multiple variable sized bilobar hypodense hepatic focal lesions for triphasic CT/ dynamic MR study.*

Dr.sherif Wagdy

Medical No. : 4492

Patient's Name: Ruth Zaka Girgis Salib

Date: 2026-09-20

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Plain X-ray Chest (PA view) revealed:

- o Obliteration of right costophrenic angle by opacity consistent with mild pleural effusion*
- o Bilateral variable size pulmonary nodules likely metastases for correlation with CT chest*
- o Average cardiac size*
- o Heterogeneous osseous texture*

Yours truly

Dr. Nermeen Ramadan.MD

٢٠٧٧/٥ ٤١٢.٣.٨٧١.٠٠٤٤٧
 رقم قلم
 التي
 منطقة سورية حتى ٢٠٤٧/٥
 ١





٢٠٧٧/٥ ٤١٢.٣.٨٧١.٠٠٤٤٧
 رقم قلم
 التي
 منطقة سورية حتى ٢٠٤٧/٥
 ١




LU2405767

33.7.7.73C

Page 1 of 1

رغم مؤهله ٢٠٢٤/١١/٢٤ ٢٠٢٤.٨.٢٧

اسم المريض ثلاثي: أحمد بن الجبر ص
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض:

بقسم رقم طبي
تتصرف بأن أوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

المزكر مريض لديه مشاكل سريرية شديدة شائعة في الجهاز الهضمي
والتنفسية والكلى وعضلاته وعظامه وسمومه
التي قد تسبب له مشاكل صحية خطيرة وخطيرة
من حيث سمومه والتهابات وارتفاع ضغط الدم
واعتلال الكلى المزمن
واعتلال الكلى المزمن

تحريراً في التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٤
الوقت:

الطبيب المعالج
د. محمد
يعتمد : :
٢

Patient's Name:
Date:
Referred by:
Hospital:

Ruth Zaka Girgis Salib
2026-09-09
Prof.Dr. no doctor
Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT CONTRAST REVEALED:-

- Moderate right pleural effusion with underlying subsegmental lung collapse/consolidation.
- Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest measuring 12 x 10 mm at the left lower lobe.
- Multiple bilateral scattered ground glass densities and reticulations with interlobular septal thickening.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No left pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Multiple scattered vertebral, ribs and left clavicular lytic bone lesions.
- Upper abdominal cuts showed multiple variable sized bilobar hypodense hepatic focal lesions.

Opinion:-

- *Moderate right pleural effusion with underlying subsegmental lung collapse/consolidation.*
- *Multiple bilateral scattered pulmonary nodules, ground glass densities and reticulations with interlobular septal thickening ? metastatic for PET-CT assessment.*
- *Multiple scattered vertebral, ribs and left clavicular lytic bone lesions likely metastatic for bone scan.*
- *Upper abdominal cuts showed multiple variable sized bilobar hypodense hepatic focal lesions for triphasic CT/ dynamic MR study.*

Dr.sherif Wagdy

Medical No. : 4492

Patient's Name: Ruth Zaka Girgis Salib

Date: 2026-09-20

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Plain X-ray Chest (PA view) revealed:

- o Obliteration of right costophrenic angle by opacity consistent with mild pleural effusion*
- o Bilateral variable size pulmonary nodules likely metastases for correlation with CT chest*
- o Average cardiac size*
- o Heterogeneous osseous texture*

Yours truly

Dr. Nermeen Ramadan.MD

٢٠٧٧/٥ ٤١٢.٣.٨٧١.٠٠٤٤٧
 رقم قلم
 التي
 منطقة سورية حتى ٢٠٤٧/٥
 ١





مملكة البحرين
 وزارة الداخلية
 إدارة جوازات السفر
 رقم الجواز: ٤١٢.٣.٨٧١.٠٠٤٤٧
 رقم القلم: ٢٠٧٧/٥
 رقم الترخيص: ١




LU2405767

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

٢٢٤٢.٠٢٢٦.٣٠٢٢٤٢

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء الطالب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض/كو. هـ. كا ميريديس

قسم رقم طبي

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج.

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

المريض/كو. هـ. كا ميريديس هـ. ٢٢/١٠/٢٠٢٢ طابخة بالقدم في انوارات
الكitchen و طابت تعاني من صعوبة في التنفس و بعض بكتيريا الكرشية

بالدم و تحتاج الى استكمال الفحوصات الطبية من اجل سرعة و كمال

و من اجل مرضه و نقل مع وف تفاحه كمن كماله

تحريراً في

الوقت: التاريخ: ٢٠٢٢/١٩/٠٤

الطبيب المعالج

.....

يعتمد ،،

رغم مؤهله ٢٠٢٤/١١/٢٦ ٢٠٢٤.١١.٢٦
اسم المريض ثلاثي: أحمد بن الجبر صا
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض:

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

المزكر كمرره ن لديه عيانه سراداح سرطان بطانة البروستا
وتنقلات الكبد وبنات عيانه بسرطان بطانة
البروستا جسيم بالبرم و صحوه حاليه حسن و يحتاج الى
متابعة مع البرم و دلفه هو حاسه و الانه
ويعرجه البشري

تحريراً في

٢٠٢٤/١١/٢٦ التاريخ:

الوقت:

الطبيب المعالج

د. محمد
مختص

يتمتع ،،